

Signal Électrique ECG

Itinéraire du dipôle - état de l'axe

prédictibles
MB - Extrême chargé -

Mouvement de déflexion

+ + - - - - - les charges + se rapprochent

Vecteurs dipôle de + au - point vers l'électrode

Potential MBR approx = -30 mV

DONC

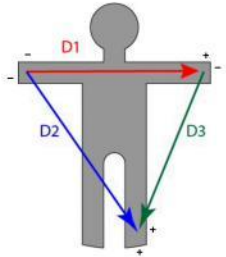
✓ Positif : Onde de dépolarisation "normale"

ou
Onde polarisée "repart"

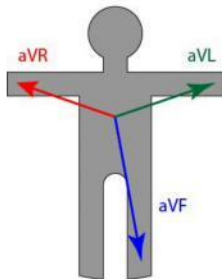
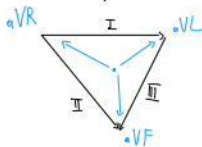
✓ Négatif : Onde de dépolarisation "part"

ou
Onde polarisée anormale

Montage Bipolaire



→ Electrode "initiale", Point Wilson au centre du cœur

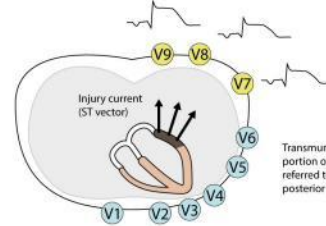


Montage Unipolaire

Electrodes Précordiales

↳ Voir le cœur sur le plan Axial

Posterolateral (posterior, inferobasal) transmural ischemia

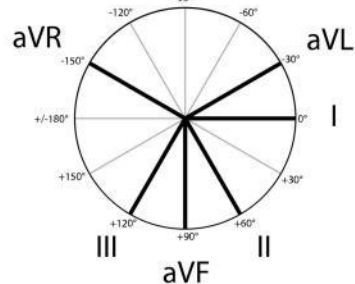
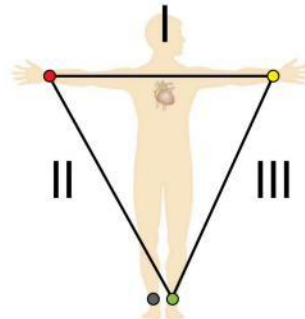


Transmural ischemia in the basal portion of the lateral wall. This is referred to as posterolateral, posterior or inferobasal ischemia.



Reciprocal ST-segment depressions

Représentation Axe Horizontale (dérivations périphériques)



Direction des dérivations périphériques et angles les séparant.

Positionner les électrodes "Rien Ne Va Plus"

Position:

V1 - 4^e Espace Inter Costal

Sternal droit

V2 - 4^e EIC, sternal gauche

V3 - entre V2 et V4

V4 - 5^e EIC, médioclaviculaire

V5 - à l'apex V4

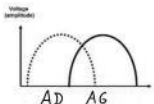
Acromion Antérieur

V6 - à l'apex V4

Acromion Postérieur

Lecture ECG

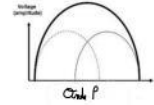
onde P → dépolarisation atriale [Dureté < 3 mm = < 120 ms]
Amplitude < 2 mm = 0,2 mV



• Hypertrophie OD
Amplitude > 2,5 mm
Amplitude @ mais deux identiques

→ D2, D3 (assez)

et V1 = Positif



• Hypertrophie OG
Dureté > 120 ms (3a)
Dureté @ mais amplitude etc

→ D1 (assez)

et V1 = Biphasique V- négatif



• Rythme Sinus Constant = P régulier

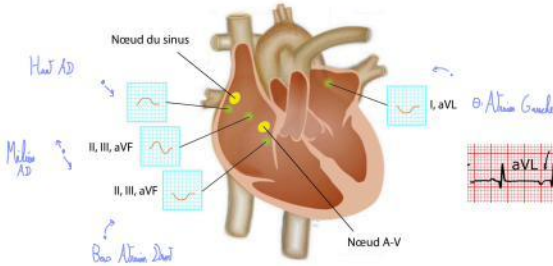


"Bas du Nœud Sinus" → "Haut"

↳ non pathologique

D3, aVF } Négatif

• Localisation une Extrait Sytob Atrial

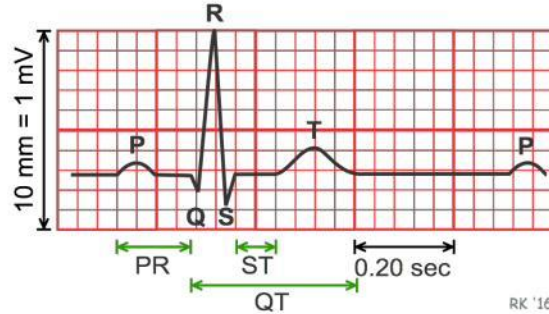


Vitesse = 25 mm/s

1 carreau = 1 mm = 0,04 s = 40 ms

1 Carre = 9 carreaux = 0,2 s = 200 ms

5 Carreaux Carreaux = 5 x 0,2 = 1 s



Amplitude → 1 mV = 1 cm = 10 mm

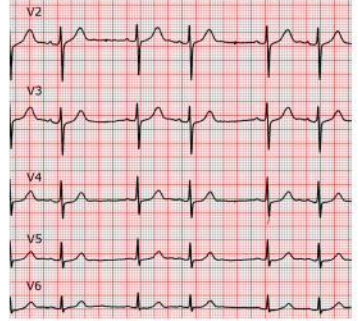
Fréquence = $\frac{300}{\text{Grand Carreau}}$
 $f = \frac{60}{p \times 0,04} = \frac{1500}{p \times 1000}$

1	2	3	4	5	6	7
300	150	100	75	60	50	42

1/2 = Bigéminisme

1/3 = Trigéminisme

Extrait Sytob Auriculaire droit Bigéminisme



lecture ECG "FRANCHI"

Fréquence $f = \frac{300}{\text{Grand Carré}}$

Rythme & Régularité

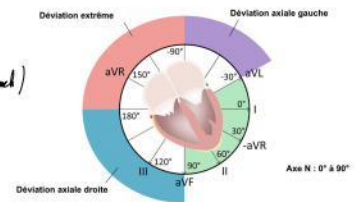
<50 = Bradycardie
>100 = Tachycardie

Régulier (glisse le doigt si motif) $\rightarrow$ NON $\rightarrow$ Tachycardie: Examen Sytôle

Sinusal: Onde "P" normale devant chaque QRS
P positif en D1; D2 & négatif aVR

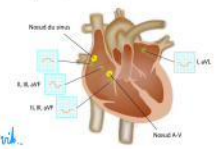
Asse des QRS $\rightarrow$

	D1	aVF	
+	+	=	Asse Normal
+	-	=	Gauche (Mieux aVF: grand)
-	+	=	Droite (D1+D2)



Arruculaire = Atrial = Supra-Ventriculaire (ESA/ESSV)

Onde "P" prémitive + Repas compensatoire $\rightarrow$ Localisation l'θ



Δ P_{PR} n'augmente pas toujours avec conduction atriale ou Ventriculaire.

Ventriculaire (ESV)

QRS long et prémitive... ressemble à un bloc de l'axe



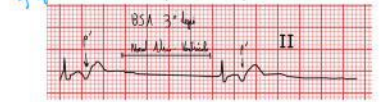
Conduction $\rightarrow$ Valeurs physiologiques: QRS < 80ms (2 cases)
PR = [120; 200] ms

Bloc Sinus-Atrial (BSA)

Manque une onde "P": J'ai manqué P sur QRS

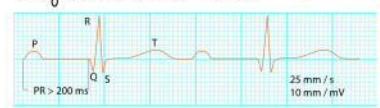


Onde P après QRS rétrograde = Atrial Normal Sinus



Bloc Atrio-Ventriculaire (BAV)

Blocage conduction Atrium $\rightarrow$ Ventricule (PR > 200ms)

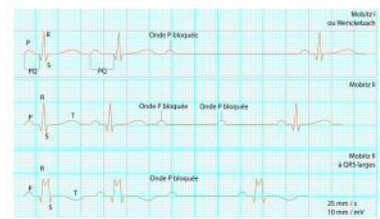


Localisation du bloc

Supra-Hissien = His intact, dépolarisé
VDJVG simultanés

QRS fins
Intra-Hissien (rare)

BAV 1°: PR long
Antécédent de P après QRS



Allongement progressif PR $\rightarrow$ P bloqué = asynchrone
PR régulier; P bloqué avec allongement progressif



BAV Complet: 2 rythmes distincts
Sinusal $\rightarrow$ P
Atrio-Ventricule $\rightarrow$ QRS

Infra-Hissien

QRS long

Ressemble BAV 2°
MAIS PR !!!
normal

